Guía de práctica clínica para la infección de vías urinarias complicada. Asociación Colombiana de Infectologí

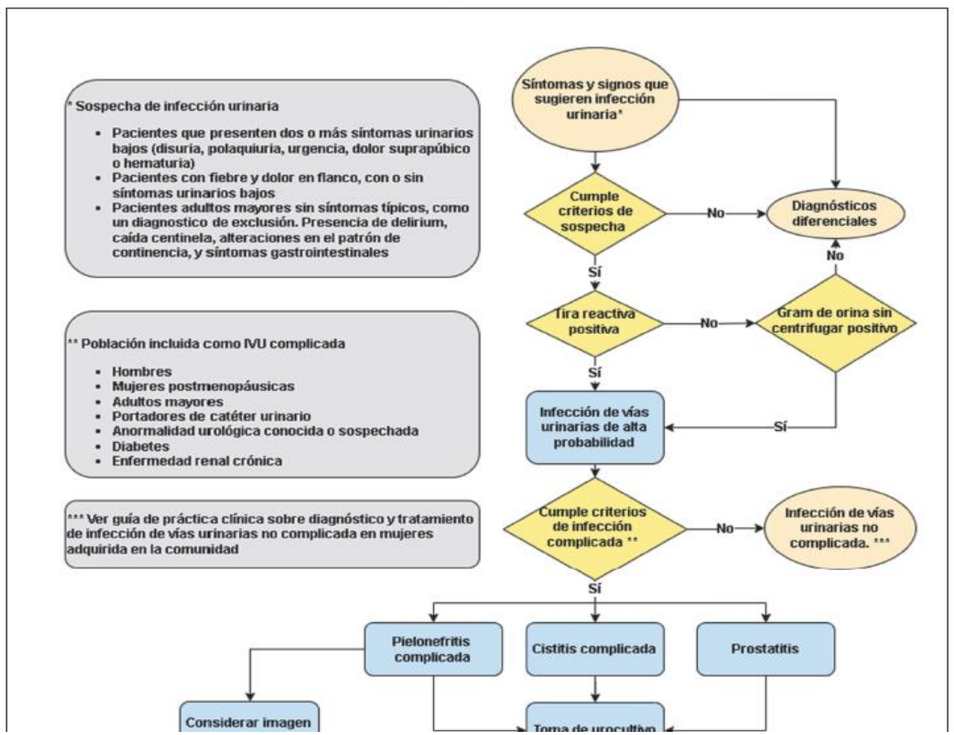
		PARÁMETRO DE EVALUACIÓN	PREGUNTA DE EVALUACIÓN	1
1	MG	Cumple con los criterios diagnósticos de IVU complicada y clasifica el caso de acuerdo con la GPC adoptada a nivel institucional.	¿Se evidencia en la historia clínica el registro de "IVU complicada" según los criterios establecidos en la actualización de la Guía de Práctica Clínica, que considera los grupos poblacionales para clasificarla como complicada? Además, ¿se distingue en el registro clínico entre cistitis complicada, pielonefritis complicada?	No cumple con los criterios diagnósticos ni la clasificación correspondiente
2	MG	Se registra la solicitud de urocultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico	¿Se evidencia que el médico registró la solicitud de urocultivo en la historia clínica y que dicha solicitud está documentada en el apartado de procedimientos?	No se evidencia el registro de la solicitud de urocultivo en la historia clínica y/o en el apartado de procedimientos
3	MG	Escoge el tratamiento empírico adecuado para la IVU complicada, seleccionando el antibiótico correcto según la clasificación de la IVU y estableciendo el horario de administración apropiado	¿El médico escoge el tratamiento empírico adecuado para la IVU complicada, seleccionando el antibiótico correcto según la clasificación de la IVU y estableciendo el horario de administración apropiado?	No se selecciona el antibiótico según GPC ni se establece el horario de administración adecuado
4	MG	La duración del tratamiento se registra de manera correcta en la historia clínica, acorde con lo establecido en la GPC y según la clasificación correspondiente	¿La duración del tratamiento se registra de manera correcta en la historia clínica, acorde con lo establecido en la GPC y según la clasificación correspondiente?	La duración del tratamiento no se registra adecuadamente en la historia clínica ni se ajusta a lo establecido en la GPC
5	MG	Se evidencia el registro del retiro o cambio del catéter urinario, en caso de que haya estado colocado por más de 30 días.	¿Se evidencia el registro del ordenamiento para el retiro o cambio del catéter urinario en caso de que haya estado colocado por más de 7 días?	No se evidencia el registro del retiro o cambio del catéter urinario, si esta condición aplica
6	ESP	Ajuste del tratamiento según reporte de urocultivo y evolución clínica	¿El especialista ajusta el tratamiento antibiótico de acuerdo con los resultados del urocultivo?	No se registra el urocultivo en la historia clínica y no se presenta un argumento en la historia clínica sobre el resultado del urocultivo ni sobre la evolución del paciente para ajustar o no el antibiótico

1	**NO CUMPLE**. La recomendación trazadora no se ha cumplido. Esto puede incluir la ausencia de la documentación correspondiente en la historia clínica, la falta de procedimiento, o la ausencia del tratamiento indicado según la recomendación.

5	**CUMPLE**. La recomendación trazadora se ha cumplido completamente. Esto significa que la documentación requerida está presente en la historia clínica, se ha ge el tratamiento ha sido establecido de acuerdo con la recomendación.

PARÁMETRO 1 - DX IVU COMPLICADA

Realice búsqueda de este parámetro en: Historia clínica de ingreso del paciente o en revaloración, elaborado por medicina general



PARÁMETRO 2 - SOLICITUD UROCULTIVO

Realice búsqueda de este parámetro en: Historia clínica de ingreso del paciente o en revaloración, elaborado por medicina general

Tabla 2. Antimicrobianos y dosis para el manejo de la IVU complicada

Antimicrobiano	Dosis	Intervalo	Ajuste renal
Intravenosos			
Cefazolina	2 g	8 horas	TFG < 50 ml/min
Cefuroxima sódica	750 mg	8 horas	TFG < 30 ml/min
Ceftriaxona	2 g	24 horas	No
Aztreonam	1 g	8 horas	TFG < 30 ml/min
Orales			
Cefalexina	1 g	8 horas	TFG < 50 ml/min
Cefuroxima axetil	1 g	12 horas	TFG < 30 ml/min
Nitrofurantoína macrocristales	100 mg	6 – 8 horas	Contraindicado en TFG < 45 ml/min
Fosfomicina-trometamol	3 g	Dosis única	Precaución en TFG < 10 ml/min

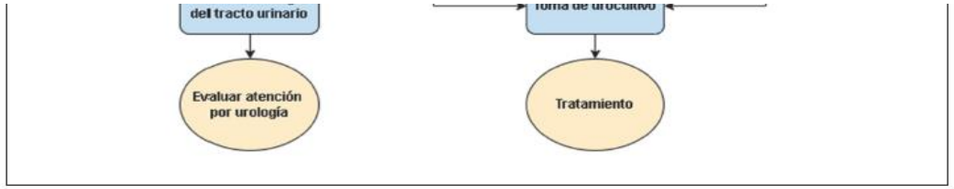


Figura 1. Algoritmo diagnóstico

a 2022	CIE- 10	N390 INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS

5
Sí, se evidenció correctamente el diagnóstico de IVU complicada y la distinción entre los subtipos (cistitis complicada, pielonefritis complicada o prostatitis) de acuerdo con la GPC
Se evidencia claramente el registro de la solicitud de urocultivo en la historia clínica y está documentada en el apartado de procedimientos
El antibiótico se selecciona según GPC y se establece de forma adecuada el horario de administración.
La duración del tratamiento se registra correctamente en la historia clínica, conforme a lo establecido en la GPC y a la clasificación correspondiente.
Se evidencia el registro del retiro o cambio del catéter urinario, o el paciente no tiene catéter, por lo que no aplica
El urocultivo se registra adecuadamente en la historia clínica, y el especialista argumenta claramente el resultado y la evolución del paciente, realizando ajustes pertinentes en el tratamiento antibiótico según sea necesario

MG	Parámetro que permite evaluar Médico General

ESP	Parámetro que permite evaluar Médico Especialista

generación de la orden respectiva para un laboratorio o

EVALUACION DE ADHERENCIA		
Calificación general	Resultado	Color
< 3.5	Malo	

nerado correctamente la orden para el laboratorio o procedimiento, y

< 3.5	Malo	
> ó = 3.5	Bueno	

PARÁMETRO 3 - TRATAMIENTO EMPÍRICO

Realice búsqueda de este parámetro en: Historia clínica de ingreso del paciente o en revaloración, elaborado por medicina general

Pielonefritis complicada	Cistitis complicada
a-Cefalosporina de primera generación en pacientes sin uso previo de antibióticos, o sin instrumentación de la vía urinaria en los últimos 3 meses	a- Nitrofurantoína como primera opción en pacientes con (TFG) ≥ 45 ml/min
b-Cefalosporina de segunda generación en pacientes con uso previo de antibióticos en los últimos 3 meses	b-Fosfomicina como alternativa oral
c-Cefalosporina de tercera generación en pacientes con historia clínica de urolitiasis, instrumentación de la vía urinaria, portadores de catéteres de la vía urinaria alta	c-Cefalosporina de primera generación (cefazolina IV) como alternativa en pacientes con manejo intrahospitalario.

PARÁMETRO 4 - DURACIÓN DE TRATAMIENTO

Realice búsqueda de este parámetro en: Historia clínica de ingreso del paciente o en revaloración, elaborado por medicina general

Duración del tratamiento establecida según la Guía de Práctica Clínica.

Pielonefritis complicada: 7 - 10 días

Cistitis complicada:

- Nitrofurantoína o cefalosporina: 5 días en mujeres postmenopáusicas.
- Fosfomicina: dosis única
- 7 días en pacientes hombres o en pacientes con IVU asociada a catéter

PARÁMETRO 5 - CAMBIO CATETER URINARIO

Realice búsqueda de este parámetro en: Historia clínica de Jefe de enfermería

PARÁMETRO 5 - AJUSTE DE TRATAMIENTO

Realice búsqueda de este parámetro en: Historia clínica de evolución, elaborado por medicina interna-urología